Diagnóstico y tratamiento VIH



Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)

¿QUÉ ES?

El VIH es un virus que ataca a las células del sistema inmune que ayudan al cuerpo a luchar contra las infecciones, lo que dificulta la lucha del cuerpo contra las infecciones y ciertas clases de cáncer.

DIAGNÓSTICO

PRUEBA #1

Prueba rápida de 3ª o 4ª generación o ELISA o quimioluminiscencia o prueba en punto de atención. Puede ser de laboratorio, en punto de atención o autotest

- **NEGATIVO**

+

PRUEBA #2

Prueba rápida diferente a la primera, inmunoensayo (ELISA o quimioluminiscencia) o prueba en punto de atención. Realizada/respaldada por laboratorio

- + **POSIBLEMENTE POSITIVO** → **INICIAR PROFILAXIS TMI**
- -

PRUEBA #3 — CARGA VIRAL (ARN)

- Brindar información
- Iniciar profilaxis TMI
- Atención integral

+ **POSITIVO** → **DETECTABLE**

- Si la 2° prueba fue *negativa*, se considera **NEGATIVO**
- Si la 2° *prueba fue positiva*, se **considera NO CONCLUYENTE**

→ **INDETECTABLE**

→ **NO CONCLUYENTE**

PRUEBA #4

- + **POSITIVO**
  - Brindar información
  - Iniciar/mantener profilaxis TMI
  - Atención integral
- ? **INDETERMINADO**
  - Mantener profilaxis TMI
  - Repetir algoritmo en 1 mes
- - **NEGATIVO**
  - Suspender profilaxis TMI
  - Seguimiento trimestral

PREVENCIÓN TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL

TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL ANTEPARTO

- Reducir la carga viral a niveles **indetectables** para disminuir el riesgo de transmisión.

PREFERIDOS

- Dolutegravir (DTG) + tenofovir disoproxil fumarato (TDF) / emtricitabina (FTC)
- Dolutegravir (DTG) + abacavir (ABC)* / lamivudina (3TC)
- Raltegravir (RAL) + tenofovir disoproxil fumarato (TDF) / emtricitabina (FTC)
- Raltegravir (RAL) + abacavir (ABC)* / lamivudina (3TC)

PROFILAXIS ANTIRRETROVIRAL INTRAPARTO

- Cesárea electiva a la semana 38 previo inicio de trabajo de parto o ruptura de membranas
- **Cesarea electiva:** zidovudina IV 3 horas antes del inicio de la cirugía.
- **Parto vaginal:** no amniotomía ni procedimientos invasivos.

PREPARACIÓN DE ZIDOVUDINA PARA INFUSIÓN ENDOVENOSA EN 100 ML DE DEXTROSA AL 5%

Peso de la gestante	Bolo de 2 mg/kg IV aplicar en una hora - Zidovudina N° de gotas	Mantenimiento 1 mg/kg/hora en infusión continua hasta el parto. Zidovudina N° de gotas
40 kilos	8 ml: 16 gotas/minuto	4 ml: 17 gotas/minuto
50 kilos	10 ml: 16 gotas/minuto	5 ml: 16 gotas/minuto
60 kilos	12 ml: 16 gotas/minuto	6 ml: 16 gotas/minuto
70 kilos	14 ml: 16 gotas/minuto	7 ml: 16 gotas/minuto
80 kilos	16 ml: 16 gotas/minuto	8 ml: 16 gotas/minuto
90 kilos	18 ml: 20 gotas/minuto	9 ml: 18 gotas/minuto

SI NO HAY CONTROLES NI TAMIZAJE PARA VIH, TOMAR PRUEBA RAPIDA EN EL MOMENTO DEL PARTO, SI ES REACTIA E INICIAR ZIDOVUDINA Y PROFILAXIS DE RECIÉN NACIDO.

VÍA DEL PARTO

- Mujer en 3° trimestre con antirretrovirales:
  - Carga viral desconocida o ≥1.000 copias/ml: **cesárea electiva semana 38.**
  - Carga viral <1.000 copias/ml: **parto vaginal**

TRAS EL PARTO

- Supresión farmacológica de lactancia materna (cabergolina)
- Leche de formula (hasta los 12 meses)
- **NO lactancia materna**

RECIÉN NACIDO

- Lavar inmediatamente con agua y jabón tras el parto
- Succión de vía aérea evitando traumatismos
- Profilaxis antirretroviral primeras 6-12 horas de vida (según clasificación de riesgo)
- Seguimiento con cargas virales según GPC

¿CÓMO SE TRANSMITE?

SEXUAL

- Relaciones sexuales penetrativas anales, vaginales u orales sin protección con una persona infectada
- Mayor parte de infecciones.

SANGUÍNEA/PERCUTÁNEA

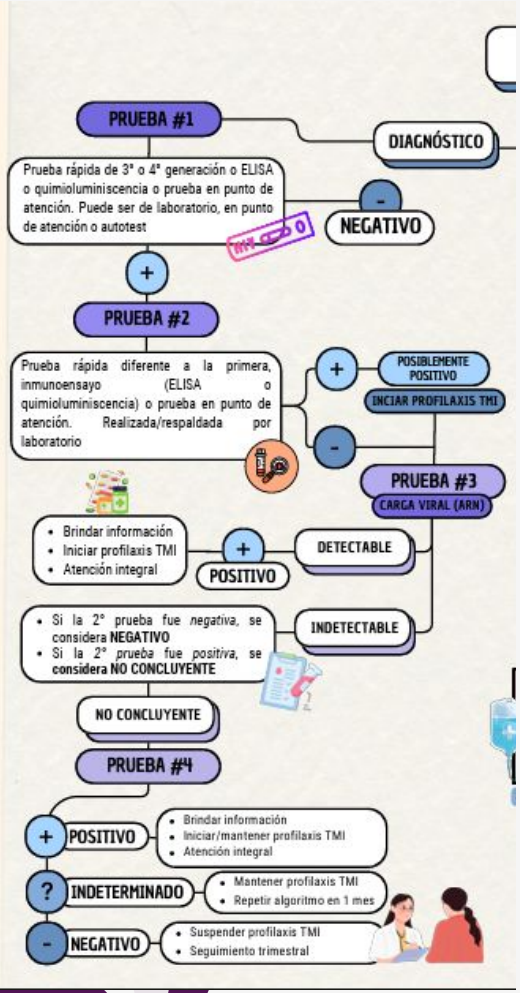
- Exposición a sangre o derivados, o tejidos transplantados de una persona infectada.
- Lesiones/heridas con elementos contaminados con VIH.

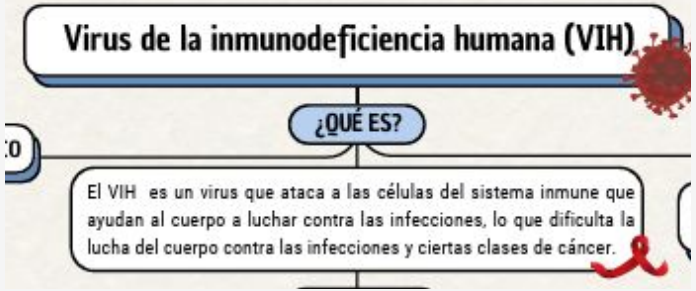
MATERNO INFANTIL

- Madre con VIH a hijo durante la gestación (10%), el parto (70%) o la lactancia (30%).

Neonatos alto riesgo TMI de VIH	Neonatos alto riesgo TMI de VIH
Al menos 1 de los siguientes criterios: • Madres que no recibieron TAR durante la gestación • Madres que solo recibieron TAR intraparto. • Madres que recibieron la TAR anteparto e intraparto, pero con CV detectable cerca al parto (2 – 4 semanas antes). • Madres con infección retroviral aguda durante la gestación • Madres con seroestatus desconocido o con prueba (+) intraparto • Recién nacidos en situación de restablecimiento de derechos con pruebas presuntivas (+) para VIH.	• Madres que recibieron TAR durante la gestación con carga viral NO detectable cerca al parto (2 – 4 semanas). • Si no se cumple este criterio, todos los casos son considerados alto riesgo.

Realizado por: Karent Tatiana Rivera Becerra
Interna Ginecología y Obstetricia Noviembre 2025





- **Lentivirus de la familia *retroviridae***

Clasificación CD4:

Estadio 0 : CD4: Cualquier valor (cualquier %) — Prueba de VIH negativa dentro de 6 meses del diagnóstico
Estadio 1: CD4: ≥500 células/mm³ (≥26%) — Sin condiciones definitorias de SIDA
Estadio 2: CD4: 200–499 células/mm³ (14–25%) — Sin condiciones definitorias de SIDA
Estadio 3 (SIDA): CD4: <200 células/mm³ (<14%) — O presencia de condición definitoria de SIDA
Estadio desconocido
CD4: No disponible (no disponible) — Información insuficiente.





Prueba VIH

Realizar prueba de VIH para todas las embarazadas lo más temprano posible en cada embarazo

- Prueba rápida para VIH (VIH 1-VIH 2). Se ofrece asesoría pre y post test para la prueba voluntaria de VIH.
- Realizar diligenciamiento de consentimiento informado.
- Realizar en cada trimestre de la gestación y en el momento del parto.
- En caso de ser el resultado positivo asegurar la toma inmediata de segunda prueba con diferente técnica.

- Carga viral y genotipo → INICIO DE ANTIRETROVIRAL. -

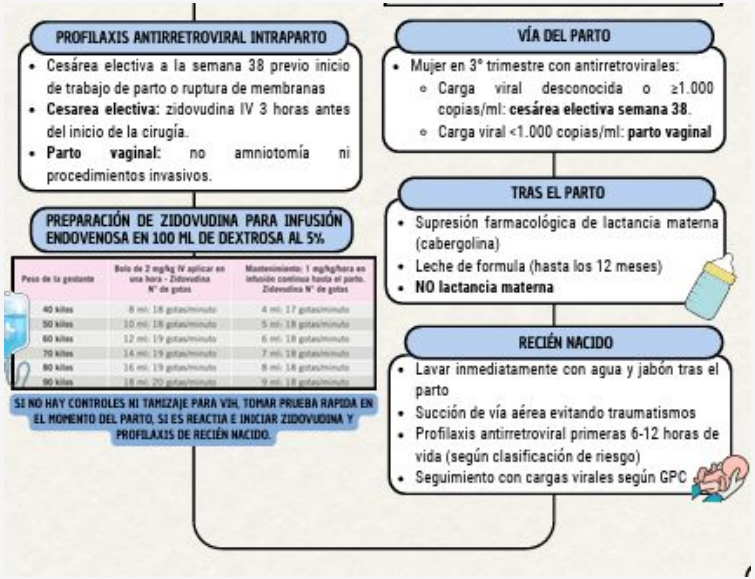
Preferido:
Dolutegravir (DTG) 50 mg + tenofovir disoproxil fumarato (TDF) 300 mg / emtricitabina (FTC) 200 mg

Alternativos:

- Raltegravir (RAL)1200 mg + tenofovir disoproxil fumarato (TDF) 300 mg / emtricitabina (FTC) 200 mg
- Darunavir/ritonavir (DRV/r) 600/100 c/12 horas + tenofovir disoproxil fumarato (TDF) 300 mg/ emtricitabina (FTC) 200mg.

Derivación multidisciplinaria:

- Odontología
- Químico farmacéutico
- Psicología
- Psiquiatría
- Trabajo social
- Medico experto
- Infectología
- Nutrición



Neonatos alto riesgo TMI de VIH	Neonatos alto riesgo TMI de VIH
Al menos 1 de los siguientes criterios: • Madres que no recibieron TAR durante la gestación • Madres que solo recibieron TAR intraparto. • Madres que recibieron la TAR anteparto e intraparto, pero con CV detectable cerca al parto (2 – 4 semanas antes). • Madres con infección retroviral aguda durante la gestación • Madres con seroestatus desconocido o con prueba (+) intraparto • Recién nacidos en situación de restablecimiento de derechos con pruebas presuntivas (+) para VIH.	• Madres que recibieron TAR durante la gestación con carga viral NO detectable cerca al parto (2 – 4 semanas). • Si no se cumple este criterio, todos los casos son considerados alto riesgo.

En los neonatos de bajo riesgo se recomienda utilizar la zidovudina oral durante 4 semanas, (4 mg/kg/dosis vía oral cada 12 horas).

Iniciar la profilaxis neonatal lo más cerca al nacimiento, idealmente en las primeras 6 a 12 horas de vida.



Peso de la gestante	Bolo de 2 mg/kg IV aplicar en una hora - Zidovudina N° de gotas	Mantenimiento: 1 mg/kg/hora en infusión continua hasta el parto. Zidovudina N° de gotas
40 kilos	8 ml: 18 gotas/minuto	4 ml: 17 gotas/minuto
50 kilos	10 ml: 18 gotas/minuto	5 ml: 18 gotas/minuto
60 kilos	12 ml: 19 gotas/minuto	6 ml: 18 gotas/minuto
70 kilos	14 ml: 19 gotas/minuto	7 ml: 18 gotas/minuto
80 kilos	16 ml: 19 gotas/minuto	8 ml: 18 gotas/minuto
90 kilos	18 ml: 20 gotas/minuto	9 ml: 18 gotas/minuto

Edad gestacional al nacer	Esquemas de profilaxis en neonatos de alto riesgo
Menor de 32 semanas	Solo zidovudina por 6 semanas
Mayor o igual de 32 semanas y menor de 34 semanas	zidovudina + lamivudina por 6 semanas
Mayor o igual de 34 semanas	zidovudina + lamivudina por 6 semanas + nevirapina por 4 semanas
Mayor o igual de 37 semanas	zidovudina + lamivudina + raltegravir* por 6 semanas o zidovudina + lamivudina por 6 semanas + nevirapina por 4 semanas

Vacunación

Condición	VHA	VHB	Influenza	Neumococo	TD/TdaP	Triple Viral	VPH	Varicela	Zoster	COVID-19	Fiebre amarilla
VIH CD4>200 células/mm^3.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VIH con recuento CD4<200 células/mm^3.		X	X*	X*	X		X*			X	